Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Joel Ignacio Rojs Pallaute				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	25/may/2015	Edad actual	10 años	10 meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Empresario M. Quiroz 308 V. Portezuelo				Teléfono	968023687	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende X habla X lee X escribe X				
Escolaridad actual:	5° bas.	Establecimiento	Básica 1.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 12/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Liliana Pallaute	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Mamá.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 12/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Ericka Calderón	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Dificultad de concentración y lectura/escritura. Requiere apoyo para aprender. No siempre copia materia. Es muy estructurado en temas de su interés. (~~considera ADOS-2~~)

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Si **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: TEL.	Terapia Ocupacional:
Neurología: TDA	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: X normal | | inducido | | fórceps | cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO | Peso: 3.340 kg. | Talla: 51 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

sin antecedentes relevantes.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~ X	Traumatismos	Sí	~~No~~ X	Encefalitis	Sí	~~No~~ X
Obesidad	Sí	~~No~~ X	Intoxicación	Sí	~~No~~ X	Meningitis	Sí	~~No~~ X
Fiebre alta	Sí	~~No~~ X	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~ X	Otra(s) —		
Convulsiones	Sí	~~No~~ X	Asma	Sí	~~No~~ X			
Hospitalizaciones	Sí	~~No~~ X	Especifique motivos y duración: —					

Se realizaron controles periódicos de salud ~~Sí~~ X No | Vacunas ~~Sí~~ X No

Observaciones:

Sin observaciones.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 m	Se sienta sólo/a: 8 m	Camina sin apoyo: 2 a
Primeras palabras: 12 m.	Primeras frases: 3 a	Se viste solo/a: 6 a.

Controla esfínter vesical — Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Controla esfínter anal — Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones: Desarrollo tardío del lenguaje. Asistio escuela de lenguaje 3 año Dg. TEL. NO fue dado de alta.

En su actividad motora general se aprecia:

X normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:

☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~ X	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~ X	Dominancia lateral	~~Sí~~ X	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~ X	No	Prensión	~~Sí~~ X	No	Pinza	~~Sí~~ X	No
Ensarta	~~Sí~~ X	No	Dibuja	~~Sí~~ X	No	Escribe	~~Sí~~ X	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~ X	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~ X	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~ X	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~ X	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~ X	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~ X

Observaciones: Presenta dificultad para dormirse, se realiza rutina diario sugerido por neurólogo.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada *En ocasiones dificultad al Tonema "R"	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones: Recomendación médica sentar cerca del pizarrón. Ojo vago, se trató con parche, actualmente estamos en tratamiento.

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma					
☒ oral ☒ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO					
Observaciones: Dificultad de modulación, especialmente fonema "R" cuando habla rápido.					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	Sonidos:	Personas extrañas:
☒ natural ☐ desmesurada	☐ natural ☒ desmesurada	☒ natural ☐ desmesurada

Observaciones: Entre los 3 y 5 años dificultad para mantener contacto visual e integrarse. Prefería juego solo. Actualmente no presenta dificultades de socialización, pero sí actitudes estructuradas con sus intereses.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales — Decreto 170/2009

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Sí	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Sí	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	X Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	X Sí	No	Otro (especifique):	Sí	No

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Rinitis osmotica, con tratamiento y controles periódicos.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer X "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): X normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo X inquieto Horas que duerme: 7 hrs, app.

X insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor

Duerme: ☐ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***

X alegre X juguetón/bromista X risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones: Insomnio no frecuentemente.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Liliana Pellante	mamá	38	4º m.	D. de casa.
2. Joan Rojo	Hermano	18	4º m.	Est. Superiores
3. Amalia Rojo	Hermano	15	2º m.	Estudiante.
4. Iñigo Rojo	Hermano	6	1º bás	Estudiante.
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Presentan a entrevista papá y mamá, aunque no viven juntos.

Observaciones:

LOS DATOS

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	3ò	Asistió a jardín infantil	Sí	~~No~~
Nº de colegios en que ha estudiado	3	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☒ Técnica ☐:		
Motivo de los cambios: esc. lenguaje – sta clara – fue mixta. tipo de educación (poco apoyo) 4º bás llega al establecimiento.				
Ha repetido curso/s	Sí ~~No~~	Curso(s)	Motivo: —	

Situación actual

Nivel/curso actual			Dificultad de aprendizaje	Sí	No	Dificultad para participar	Sí	No	Conducta disruptiva	Sí	No
Asiste regularmente	Sí	No	Asiste con agrado	Sí	No	Apoyo familiar en tareas	Sí	No	Amigos (as)	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☒ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☐ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☐ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

* le ha descontrolado pocas veces, pero fuerte, debido a frustraciones, aparentemente pequeñas.
Ej: le sacan 1 carta, desordena sus juguetes, sin embargo, la mayoría de las veces se controló. (pataleta de llanto).
* Tiene apoyo en casa constantemente.
* Fue medicado 6 meses y luego lo suspendió por efectos secundarios. (Insomnio e inapetencia).

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY